



# VENERE

Il primo operatore nazionale della medicina estetica in Italia

Buy-and-build nel settore più frammentato e in crescita della sanità privata pay-per-service — e un dataset clinico proprietario che, nel tempo, industrializza la qualità e riduce la dipendenza dal medico.

## L'OPPORTUNITÀ

# Un mercato grande, senza un proprietario, con la finestra aperta

**800k+**

procedure l'anno in Italia (500k non chirurgiche, 300k interventi)

**90%+**

degli studi indipendente e mono-medico: nessuna catena domina

**0**

consolidatori buy-and-build con capitale istituzionale attivi oggi

**3-4x**

EBITDA d'ingresso degli studi, spesso in uscita generazionale

### L'Europa è già partita

UK: sk:n e Harley Medical aggregate. Il capitale istituzionale arriverà anche in Italia — chi costruisce prima detta i prezzi.

### Vento GLP-1

I farmaci per la perdita di peso creano domanda ricorrente: rimodellamento e skin quality post-dimagrimento.

### Ricambio generazionale

Titolari verso la pensione senza successori: venditori motivati, aperti a earn-out e permanenza clinica.

*È la fotografia del dentale e delle farmacie italiane prima del consolidamento. Ogni trimestre di attesa alza i multipli e avvicina i consolidatori esteri.*

# Il modello ha già vinto: USA medspa, dentale e farmacie italiane

## USA · Medspa — la scala paga

- ◆ Studio mono-medico 3-6x EBITDA; piattaforma con recurring 30%+ 7-12x
- ◆ I membri valgono 4,8x il lifetime value e spendono +35% a visita
- ◆ 2026 anno record M&A: LaserAway in vendita >2 mld \$

## Italia · Sanità-retail — già eseguito qui

- ◆ Stessa struttura: mono-professionista, contabilità artigianali, zero brand
- ◆ Dentale (DentalPro, Primo+Caredent) e farmacie (Hippocrates): da studi grigi a catene nazionali via PE
- ◆ La lezione: vince M&A disciplinato + trasformazione operativa, non la tecnologia

**La medicina estetica ha 3 vantaggi strutturali:** 100% pay-per-service senza convenzioni, ricorrenza naturale 3-4 visite/anno, margini lordi superiori sugli iniettabili.

# Due motori di valore: arbitraggio dei multipli e trasformazione del formato



Compriamo **flussi di cassa esistenti** (rischio d'impresa già pagato dal venditore) e li trasformiamo con un formato replicabile. Anche senza espansione dei multipli, la sola crescita dell'EBITDA per clinica e l'effetto scala generano ritorno: **l'arbitraggio è il moltiplicatore, non la scommessa.**

# Sei caratteristiche: cosa cambia in ogni clinica acquisita

## **Recurring su prescrizione**

Percorsi programmati a pagamento mensile + membership. Target 15-20% ricavi ricorrenti a 24 mesi, 30% a regime.

## **Multi-provider by design**

2+ medici e protocolli condivisi: il paziente è fedele al brand e al percorso, non al singolo.

## **Mix clinico completo**

Iniettabili, energy-based, rigenerativa, post-GLP-1: più categorie e più visite per paziente.

## **Patient journey da retail**

Beauty advisor, consulenza strutturata, follow-up e recall automatici: esperienza premium.

## **Pagamenti rateali integrati**

Rateizzazione a tasso zero: alza il ticket e apre la fascia 25-40, già abituata al buy-now-pay-later.

## **Gestione manageriale**

GM di area, KPI settimanali (saturazione, conversione, retention), procurement e marketing centrali.

*Ogni elemento è già validato nel mercato USA; l'insieme non esiste ancora in nessuna clinica italiana.*

# La formalizzazione è il motore del valore, non un costo

Il settore è frammentato, a pagamento e in gran parte informale: **è proprio questo a deprimere i multipli d'ingresso**. Il consolidatore che porta trasparenza cattura il re-rating — come già visto nel dentale/diagnostica in Brasile e India (da studi grigi a piattaforme quotate a multipli premium).

## Rateizzazione = tracciabilità

Il pagamento mensile su carta/finanziaria rende il ricavo bianco e allarga il mercato (affordability). Formalizzi crescendo.

## Rollover in equity

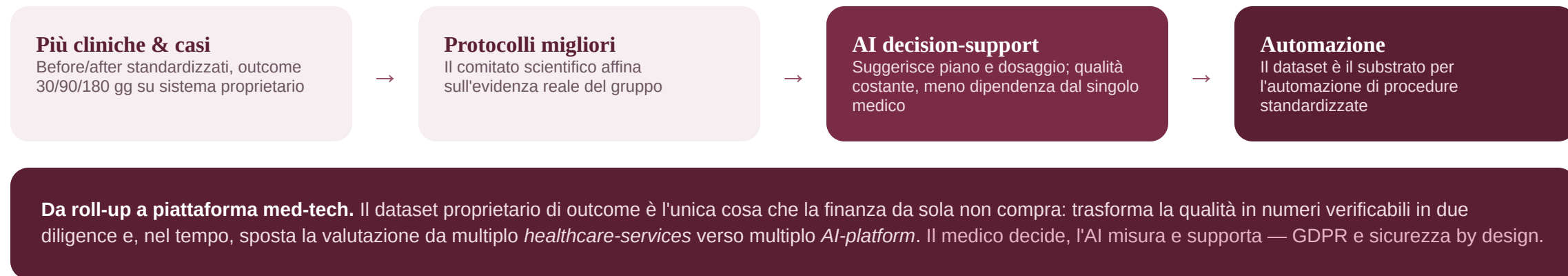
Il medico converte reddito da lavoro in una quota della piattaforma: incentivo legale ad allinearsi e regolarizzare.

## Compliance = multiplo

Un asset pulito, fatturato e bancabile vale 7-10x; gli studi grigi 3-4x. La regolarizzazione è l'espansione del multiplo — e il moat.

*Governance clinica dominante e incentivi mai legati ai volumi: formalizzare senza iper-commercializzare (la lezione dei consolidamenti falliti).*

# Ogni clinica rende il gruppo più intelligente



# La clinica resta medica, la piattaforma fa il resto, i presidi evitano i disastri

## Area clinica (per sede)

Direttore sanitario e autorizzazioni per struttura; équipe multi-medico; piena autonomia clinica; comunicazione solo informativa.

## Piattaforma di gruppo

M&A e finanza; brand, marketing, percorsi; procurement centralizzato; GM di area, HR, software e KPI.

## Comitato scientifico

Indipendente, sopra il CMO: protocolli e audit outcome.

## Incentivi $\neq$ volumi

Mai bonus sul venduto: si premia sicurezza e retention.

## Audit & mystery patient

Controlli periodici per sede e sulla consulenza.

## Soglie reputazionali

KPI con blocco di marketing ed espansione al bisogno.

*Allineamento: i medici venditori reinvestono in equity (rollover) con earn-out legato alla permanenza.*



# Cosa compriamo, a quanto, e come strutturiamo

## Criteri del target

- ◆ Ricavi 0,8-2,5M, EBITDA 20%+ verificato con normalizzazione
- ◆ Bacino 100k+ ab.; cluster regionali (NO, NE, Roma)
- ◆ Base pazienti 1.500+ con iniettabili/ripetibili prevalenti
- ◆ 2+ medici o convertibile a multi-provider entro 12 mesi
- ◆ Titolare disponibile a permanenza 24-36 mesi

## Struttura tipo

- ◆ Prezzo 3-4x EBITDA normalizzato
- ◆ 60-70% cash al closing
- ◆ 15-20% earn-out su risultati a 24 mesi
- ◆ 15-25% rollover equity nella piattaforma
- ◆ Non-compete e patti di permanenza

## Pipeline proprietaria

Origination dal network clinico, congressi, fornitori di iniettabili/dispositivi (che conoscono i volumi reali) e advisor locali — inclusi i fondatori di consolidamenti sanitari italiani come advisor. Il deal flow migliore non passa dai broker.

## ROADMAP

# Dal format lab al primo operatore nazionale

### FASE 1 · MESI 0-18

#### Provare il formato

Format lab + prime cliniche nel primo cluster.  
Dimostrazione dell'uplift EBITDA/clinica. Avvio raccolta dati.

**KPI: recurring 10%+, EBITDA/clinica +30%**

### FASE 2 · MESI 18-36

#### Densità regionale

8-12 cliniche in 2-3 cluster. Playbook 100 giorni,  
procurement pieno, brand nazionale, leva bancaria.

**KPI: 10+ sedi, recurring 20%+, EBITDA 4-6M**

### FASE 3 · MESI 36-60+

#### Scala nazionale ed exit

20-30 cliniche + dataset maturo (decision-support).  
Piattaforma target dei consolidatori PE / device-maker.

**Exit: PE / strategico a 7-10x, upside med-tech**

*Il data play matura come layer trasversale: da moat di qualità (Fase 1) a decision-support (Fase 2-3) a opzione di automazione (oltre).*

# La trasformazione di una clinica tipo in 24 mesi

| Clinica tipo   | All'acquisto | A 24 mesi           |
|----------------|--------------|---------------------|
| Ricavi         | 1,20M        | <b>1,75M</b> (+45%) |
| Margine EBITDA | 20%          | <b>27%</b>          |
| EBITDA         | 240k         | <b>480k</b>         |

Numeri illustrativi da benchmark di settore, da validare in DD sulle prime cliniche.

### Ricavi +45%

Percorsi + recall, mix ampliato, rateizzazione, saturazione col secondo medico.

### Margine 20% → 27%

Procurement (sconti volume 10-20%), marketing di gruppo, back office condiviso, pricing disciplinato.

### Ritorno sull'acquisizione

Comprata ~3,5x (840k), genera 480k EBITDA a regime: rende già a livello di singola sede, prima di ogni effetto piattaforma.

# Chi c'è oggi in Italia e perché lo spazio è vuoto

|                    | Modello                       | Proprietà cliniche      | Recurring            | Capitale ist.          |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Clinic Italia      | Franchising, ~15 studi        | No (affiliazione)       | Assente              | No                     |
| Juneco             | Retail centri commerciali     | Sì, footprint limitato  | Assente              | Privati                |
| Studi indipendenti | Mono-medico, artigianale      | Sì (titolare)           | Assente              | No                     |
| VENERE             | Buy-and-build + format + dati | Sì, con rollover medici | Cuore (30% a regime) | Family office + debito |

**La differenza non è il marketing, è il modello.** Nessuno compra cliniche profittevoli, le trasforma con un format a ricavi ricorrenti, allinea i medici con equity e costruisce un dataset. Chi occupa per primo lo spazio diventa il compratore naturale di tutti gli altri.

# Visione tech, clinica, operations — complementari

## Founder & CEO

Imprenditore tech, fondatore e CEO di un gruppo AI enterprise in fase di exit. Guida visione, capitale, M&A, investitori — e porta il **moat software/dati** che nessun consolidatore finanziario ha.

## Chief Medical Officer

Medico chirurgo con attività di medicina estetica su più sedi. Protocolli, format clinico, reclutamento medici e deal flow dal network. Sotto il comitato scientifico indipendente.

## COO • AD operativo

Manager di reti multi-sede in sanità e consumer premium. Format e P&L per sede, patient journey, integrazione a 100 giorni.

Finanza e contrappesi per costruzione: funzione CFO espressa dagli anchor investor; deal team M&A dedicato; comitato scientifico indipendente, consigliere indipendente in board, advisor regolatorio-sanitario e fiscale-M&A; advisor da consolidamenti sanitari italiani già eseguiti.

L'ORIZZONTE

# Un asset che l'AI non erode, ma potenzia — e un secondo atto oltre i 10 anni

## Non-disruptabile

L'atto medico è fisico, autorizzato, locale. L'AI qui è un tailwind operativo, non una minaccia sul ricavo.

## Runway 5-10 anni

Più consolidi, più il multiplo si espande e più diventi il #1 nazionale: la scala lavora a favore.

## Oltre: automazione

Il dataset apre la strada all'automazione delle procedure standardizzate: da servizi a med-tech.

VENERE · Riservato e confidenziale

# Cosa può andare storto, e come l'abbiamo progettato

## Dipendenza dal medico

Multi-provider obbligatorio, rollover ed earn-out sulla permanenza, fedeltà al brand e al percorso.

## Regolatorio e deontologico

Struttura MSO, comitato scientifico, comunicazione conforme, advisor regolatorio dal giorno uno.

## Qualità dei bilanci target

DD con normalizzazione ricavi, prezzo su EBITDA verificato, earn-out che sposta il rischio sul venditore.

## Ciclicità dei consumi

Percorsi ricorrenti che stabilizzano i flussi, rateizzazione, mix a manutenzione ricorrente.

## Esecuzione M&A

Playbook 100 giorni nel software, Fase 1 piccola per raffinare il metodo prima di scalare.

## Consolidatori esteri

La velocità è la difesa: chi ha già cluster e format diventa la piattaforma da comprare.

*Il rischio n°1 resta reputazione e qualità clinica: per questo un intero sistema di governance clinica con soglie di blocco.*

# Raccolta iniziale: 12 milioni per costruire la piattaforma

**70%**

Acquisizione delle prime 6-8 cliniche  
(equity + leva in Fase 2)

**15%**

Capex del format: offerta, dispositivi,  
restyling

**10%**

Piattaforma centrale: management,  
M&A, brand, software

**5%**

Riserva operativa e costi di transazione

**Struttura:** club deal di family office con governance attiva (board seat e CFO espressi dagli anchor), tranche legate a milestone di acquisizione. Orizzonte 5-6 anni, exit a PE/strategico, target 7-10x EBITDA e MOIC 2,5-3,5x — con upside dal dataset.

**Primo passo:** commitment sulla **Fase 1 (4-5M)** per le prime cliniche e la prova del format, con diritto di prelazione sulle tranche successive. Il resto del capitale si chiama solo a metriche dimostrate.





# VENERE

Il primo operatore nazionale della medicina estetica — e la piattaforma di dati che lo rende difendibile nel tempo.

Compriamo cliniche profittevoli, le trasformiamo con un format a ricavi ricorrenti, formalizziamo un settore grigio e costruiamo il dataset che industrializza la qualità. Un mercato grande, senza proprietario, con la finestra aperta.